2025 OBESITY FACT SHEET

2025 비만 팩트시트

10주년 기념 10th

KOREAN SOCIETY FOR THE STUDY OF OBESITY

h·well 국민건강보험

발간사

대한비만학회 회원 및 비만 문제에 깊은 관심을 가져주시는 모든 분들께,

대한비만학회는 올해도 「Obesity Fact Sheet 2025」를 발간하게 되었습니다. 특히 올해는 Fact Sheet 발간 10주년을 맞이하는 뜻깊은 해입니다. 지난 10년간 「Obesity Fact Sheet」는 건강보험공단(National Health Insurance Service, NHIS) 및 질병관리청의 국민건강영양조사(Korean National Health and Nutrition Examination Survey, KNHANES) 자료를 기반으로 우리나라 비만의 현황과 변화를 제시하며, 정책 수립과 임상 진료의 방향을 논의하는 데 중요한 근거 자료로 활용되어 왔습니다.

2025년 자료에 따르면, 우리나라 성인 비만율은 꾸준히 증가해 오다가 최근 3년간 약 38% 수준에서 정체되어 있습니다. 이는 증가세가 다소 완화되었다는 점에서 긍정적인 의미가 있으나, 여전히 성인 세 명 중 한 명 이상이 비만이라는 사실은 심각한 공중보건 과제로 남아 있습니다. 소아·청소년 비만은 코로나19 시기에 급격히 증가하였다가 최근 2019년 수준으로 회복되었지만, 생활습관과 환경적 요인이 개선되지 않는다면 언제든 재확산될 수 있음을 시사합니다.

한국의 비만은 성별과 연령에 따라 뚜렷한 차이를 보입니다. 여성보다 남성에서 비만이 더 심각하며, 특히 20~30대 젊은 남성에서 고도비만이 빠르게 증가하는 것은 향후 이 연령대에서 대사질환, 심혈관질환, 근골격계 질환의 조기 발생 위험이 높아질 수 있음을 보여줍니다. 올해 Fact Sheet에서는 연령과 성별에 따른 비만 관련 동반질환의 위험도를 분석하였으며, 부모의 비만이 자녀의 비만으로 이어지는 가족적 연관성을 확인하여, 비만이 단순히 개인의 문제가 아니라 세대 간 건강 불평등으로 확산될 수 있음을 강조하였습니다.

대한비만학회는 이러한 통계적 시사점을 바탕으로, 비만을 예방·치료·관리해야 할 만성질환으로 인식하는 국제적 흐름에 발맞추어 학문적 연구, 임상 진료, 국가 정책 제안에 앞장서 왔습니다. 특히 올해 ICOMES 2025를 통해 미국비만학회, 유럽비만학회는 물론 아시아를 포함한 전 세계와의 국제적 협력과 학술 교류를 더욱 강화하여, 비만 문제 해결에 실질적으로 기여하고자 합니다.

「Obesity Fact Sheet 2025」가 의료진, 연구자, 정책 입안자는 물론 일반 국민에게도 널리 활용되어, 우리 사회의 비만 예방과 치료에 실질적 변화를 이끌어내기를 기대합니다. 끝으로, Fact Sheet 발간을 위해 헌신해 주신 대한비만학회 빅데이터위원회 한경도 이사님, 정수민 간사님을 비롯한 모든 위원님들께 깊이 감사드립니다.

대한비만학회 회장
서영성

대한비만학회 이사장
김민선

2025 비만 팩트시트 Task Force Team

편집장	**한경도**	숭실대 정보통계보험수리학과
부편집장	**정수민**	서울의대 의학과
편집위원	**구유정**	서울대학교 강남센터 내분비내과
	구혜연	서울의대 분당서울대병원 가정의학과
	김미경	가톨릭의대 은평성모병원 내분비내과
	김봉성	가톨릭의대 내과학교실
	김원석	을지의대 의정부을지대병원 가정의학과
	김에스더	서울의대 서울대병원 가정의학과
	김지영	서울의대 서울대병원 가정의학과
	남가은	고려의대 구로병원 가정의학과
	박계영	한양의대 서울병원 가정의학과
	백종하	경상의대 창원경상대병원 내분비대사내과
	선정연	국민건강보험공단
	양예슬	서울의대 의학과
	조신영	서울의대 서울대병원 가정의학과
	조인영	성균관의대 삼성서울병원 가정의학과
자문	**박용문**	University of Arkansas for Medical Sciences

발행일 2025. 09. 04.
발행인 김민선, 대한비만학회 이사장
편집인 한경도, 대한비만학회 빅데이터위원회 이사
발행처 대한비만학회
출판 인권앤파트너스
ISSN 2982-4966

목차

2 발간사
3 2025 비만 팩트시트 Task Force Team
5 자료원 및 자료 기술 / 비만 및 복부비만의 정의
6 요약

1. 최근 10년간 (2014-2023년) 성인 비만 및 복부비만 유병률

9 성인의 비만 및 복부비만 유병률
11 연령별 비만 및 복부비만 유병률

2. 성인의 비만 단계별 유병률

14 성, 연령별 비만 유병률
15 비만 단계별 유병률 (5세 연령 구간 기준)
18 성, 연령별 복부비만 유병률 (5세 연령 구간 기준)
19 성, 연령별 저체중 유병률 (5세 연령 구간 기준)

3. 비만에서 만성질환 유병률

21 만성질환 정의
22 고혈압 및 대사 질환 유병률
27 근골격계 질환 유병률
29 정신 및 수면관련 질환 유병률
31 만성콩팥병 유병률

4. 최근 10년간 (2014-2023년) 소아청소년 과체중 및 비만 유병률

33 소아청소년 과체중 및 비만 유병률
35 소아청소년 연령별 비만 유병률
37 성별에 따른 소아청소년 1세 단위 과체중 및 비만 유병률

5. 부모의 비만과 자녀의 비만

42 부모 체질량 지수와 자녀의 비만
45 부모의 비만과 자녀의 비만
46 자녀 구성 유형과 자녀의 비만 유병률

47 대한비만학회 이사진
48 비만 팩트시트 10년 주요 연혁 (2015-2024)
50 비만 팩트시트 표지 아카이브 (2015-2024)
52 비만 팩트시트 기반 연구
54 비만 팩트시트 10주년을 축하하며

자료원

국민건강보험공단

국민건강보험공단의 국민건강보험서비스(National Health Insurance Service, NHIS)에서 제공하는 2014년부터 2023년까지의 일반건강검진을 받은 성인을 대상으로 함.

국민건강영양조사

질병관리청에서 제공하는 국민건강영양조사(Korea National Health and Nutrition Examination Survey, KNHANES) 제6기 2차년도(2014년)부터 제9기 2차년도(2023년)까지의 자료를 이용하였으며, 비만에서 만성질환 유병률은 국민건강영양조사에 참여한 19세 이상 성인을 대상으로, 소아청소년 비만은 국민건강영양조사에 참여한 6~18세 소아청소년을 대상으로 함.

자료기술

· 전체 및 성별, 연령층에 따른 비만 및 복부비만, 단계별 비만을 기술함.
· 유병률은 2010년 통계청 인구주택총조사 자료에 기초하여 성, 연령 표준화하여 표시함.
· 부모의 비만과 자녀의 비만은 10~18세 소아청소년을 대상으로, 부모의 비만 여부와 자녀의 비만 간의 관련성을 로지스틱 회귀모형으로 분석하였으며, 자녀의 성별과 연령을 보정한 오즈비(OR)로 제시함.

성인의 비만 및 복부비만의 정의

· 비만은 세계보건기구의 아시아-태평양 기준에 따라 체질량지수(체중[kg]/신장[m]^2) 25 kg/m^2 이상으로 정의함.[1)]
· 단계별 비만의 정의는 대한비만학회 2022년 비만 진료지침 권고에 따름.[2)]
① 1단계 비만: 체질량지수 25-29.9 kg/m^2
② 2단계 비만: 체질량지수 30-34.9 kg/m^2
③ 3단계 비만: 체질량지수 35 kg/m^2 이상
저체중은 체질량지수 18.5 kg/m^2 미만으로 정의함.
· 복부비만은 대한비만학회에서 권고하는 한국인 복부비만 정의에 따라 허리둘레가 남자는 90 cm 이상, 여자는 85 cm 이상으로 정의함.[2), 3)]

소아청소년 비만의 정의

· 소아청소년 비만은 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 성, 연령별 체질량지수 백분위수를 사용하여 체질량지수 85~94백분위수는 과체중, 95백분위수 이상은 비만으로 정의함.

1) WHO. The Asia-Pacific perspective: Redefining obesity and its treatment. 2000
2) Kim KK, et al. Evaluation and Treatment of Obesity and Its Comorbidities: 2022 Update of Clinical Practice Guidelines for Obesity by the Korean Society for the Study of Obesity. J Obes Metab Syndr 2023;32:1-24
3) Lee SY, et al. Appropriate waist circumference cutoff points for central obesity in Korean adults. Diabetes Res Clin Pract 2007;75:72-80

요약

1. 최근 10년간 (2014-2023년) 성인 비만 및 복부비만 유병률

· 전체 성인의 비만 및 복부비만 유병률은 지속적 증가 추세를 보이다가, 최근 3년간 비슷한 수준을 유지함. (2023년 비만 유병률: 38.4%, 복부비만 유병률: 24.3%)
· 남자에서는 비만 유병률이 지속적으로 증가하고, 여자에서는 2021년부터 비슷한 수준으로 유지됨. (2023년 비만 유병률 남자: 49.8%, 여자: 27.5%)
· 남자에서 복부비만 유병률은 지속적으로 증가하고, 여자에서는 2019년 이후로 감소 추세임. (2023년 복부비만 유병률 남자: 31.3%, 여자: 17.7%)
· 연령별로 보면 30대에서 42.0%, 40대에서 42.2%로 가장 높은 비만 유병률을 보이며, 20대 비만 유병률은 22.7% (2014년)에서 32.0% (2023년)로 가파르게 증가하고 있음.
· 연령별 복부비만 유병률은 대부분의 연령대에서 전반적으로 유지 및 감소 추세이나, 20대와 40대에서는 지속적으로 증가 추세임. (2023년 복부비만 유병률 20대: 16.1%, 40대: 26.1%)

2. 성인의 비만 단계별 유병률

· 전체 성인의 1단계 비만 유병률은 70-74세 연령대에서 35.6%로 가장 높음.
· 성별에 따른 1단계 비만 유병률은 남자 45-49세 연령대에서 44.0%, 여자 75-79세 연령대에서 36.0%로 가장 높음.
· 전체 성인의 2단계, 3단계 비만 유병률은 30대에서 가장 높음. 2단계 유병률은 35-39세 연령대에서 9.4%, 3단계 비만 유병률은 30-34세 연령대에서 2.57%로 가장 높음.

3. 비만에서 만성질환 유병률

· 비만인 경우 비만이 아닌 경우보다 고혈압 (1.9배), 당뇨병 (2.1배), 고콜레스테롤혈증 (1.5배), 대사증후군 (3.1배), 고요산혈증 (2.4배), 골관절염 (1.5배), 폐쇄성 수면무호흡증 (5.2배), 만성콩팥병 (1.4배) 유병률이 높으며, 이러한 차이는 젊은 연령, 여자에서 더 뚜렷하게 확인됨.
· 골다공증 유병률은 비만인 경우가 비만이 아닌 경우보다 낮음. (0.8배)
· 우울증 유병률은 전체 성인에서는 차이가 없었으나 여자에서 비만인 경우 우울증 유병률이 비만이 아닌 경우보다 1.3배 높음.

4. 최근 10년간 (2014-2023년) 소아청소년 과체중 및 비만 유병률

· 전체 소아청소년의 비만 유병률은 증가 추세를 보이다가, 2021년 이후로 감소 추세를 보여 2023년 비만 유병률은 13.8%로 코로나19 유행 직전인 2019년과 비슷한 수준을 보였음.
· 전체 소아청소년의 과체중 및 비만 유병률은 증가 추세를 보이다가, 2021년 이후로 감소 추세를 보임.
· 남아에서의 과체중 및 비만 유병률은 8세부터 증가하여 14세에 28.3%로 가장 높으며, 여아에서의 과체중 및 비만 유병률은 16세부터 증가하여 17세에 26.7%로 가장 높음.

5. 부모의 비만과 자녀의 비만

· 부모의 체질량 지수가 높을수록 자녀가 비만일 확률은 증가하여, 아버지나 어머니가 2단계 비만 이상일 때 자녀가 비만할 확률은 5배 이상 증가함.
· 남아의 비만은 아버지의 비만에 더 영향을 많이 받고, 여아의 비만은 어머니의 비만에 더 영향을 많이 받음.
· 외동의 비만 유병률 (14.0%)이 다자녀의 비만 유병률 (13.1%)보다 높고, 첫째 자녀의 비만 유병률 (15.1%)이 둘째 이상인 자녀의 비만 유병률 (11.0%)보다 높음.

1. 최근 10년간 (2014-2023년) 성인 비만 및 복부비만 유병률

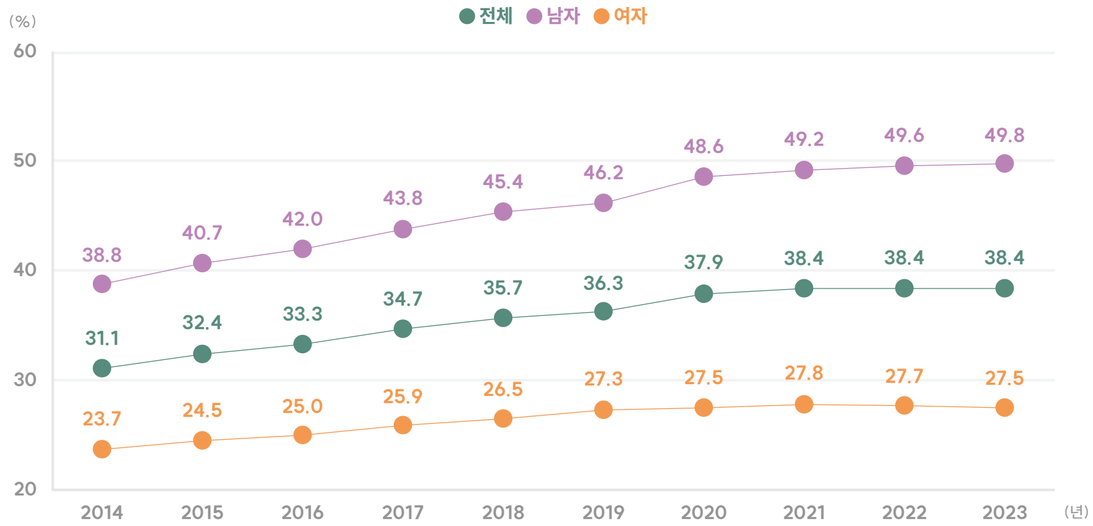
성인의 비만 및 복부비만 유병률

연령별 비만 및 복부비만 유병률

*2014-2023년 국민건강보험공단 일반건강검진 자료를 분석함.

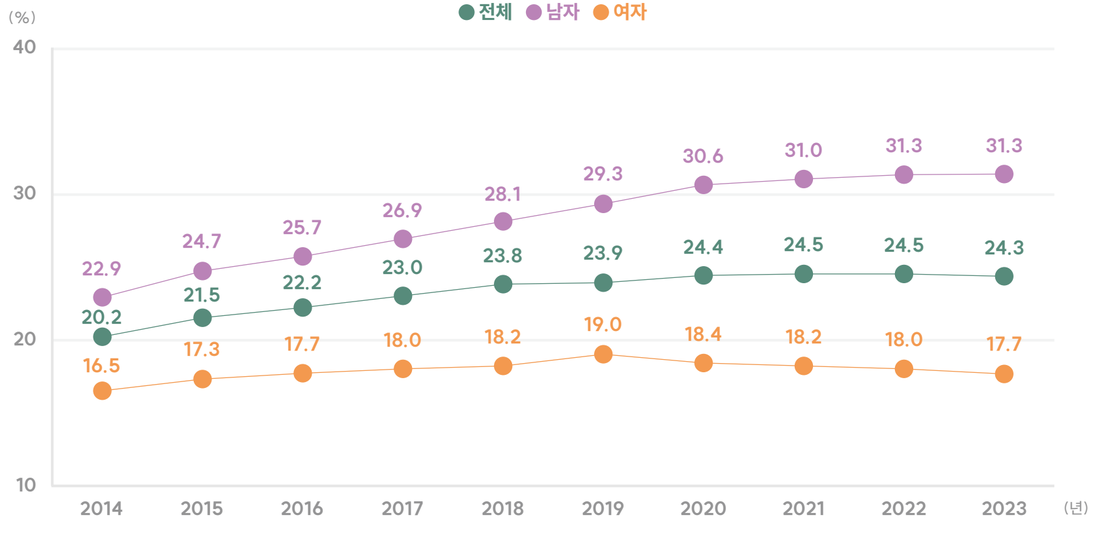
최근 10년간 비만 유병률

전체 성인의 비만 유병률은 지속적 증가 추세를 보이다가,
최근 3년간 비슷한 수준을 유지함. (2023년 38.4%)
남자에서는 지속적으로 증가했으나, 여자에서는 2021년부터 비슷한 수준으로 유지됨.
2023년 비만 유병률은 남자에서 49.8%, 여자에서 27.5%임.



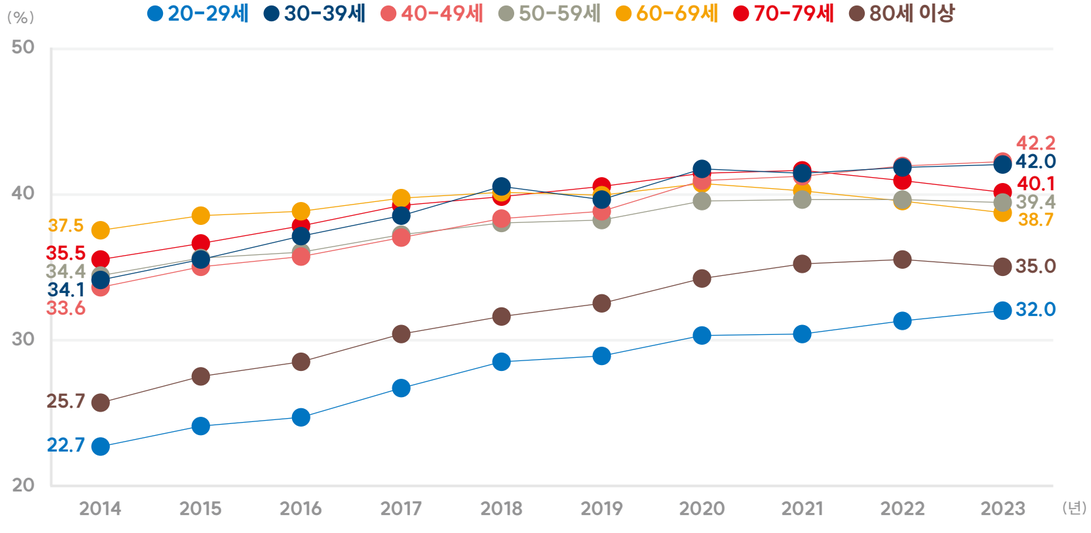
최근 10년간 복부비만 유병률

전체 성인의 복부비만 유병률은 지속적 증가 추세를 보이다가,
최근 3년간 비슷한 수준을 유지함. (2023년 24.3%)
남자에서 복부비만 유병률은 지속적으로 증가했으나, 여자에서는 2019년 이후로 감소 추세임.
2023년 복부비만 유병률은 남자에서 31.3%, 여자에서 17.7%임.



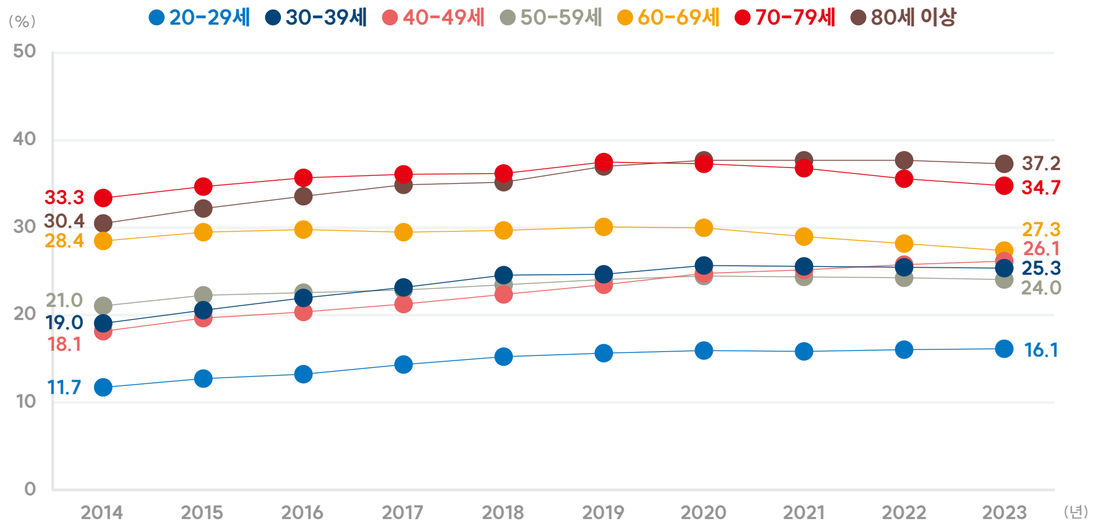
최근 10년간 연령별 비만 유병률

비만 유병률은 대부분의 연령대에서 전반적으로 증가 추세이나, 60-70대에서는 최근 감소 추세임.
30대와 40대에서 가장 높은 비만 유병률을 보임. (2023년 30대 42.0%, 40대 42.2%)
20대의 비만 유병률은 다른 연령군에 비해 낮으나 지속적으로 크게 증가하고 있음. (2023년 32.0%)



최근 10년간 연령별 복부비만 유병률

복부비만 유병률은 대부분의 연령대에서 전반적으로 유지 및 감소 추세임.
하지만 20대와 40대에서는 지속적으로 증가 추세임. (2023년 20대 16.1%, 40대 26.1%)
60대와 70대의 복부비만 유병률은 2019년부터 지속적으로 감소 추세임.



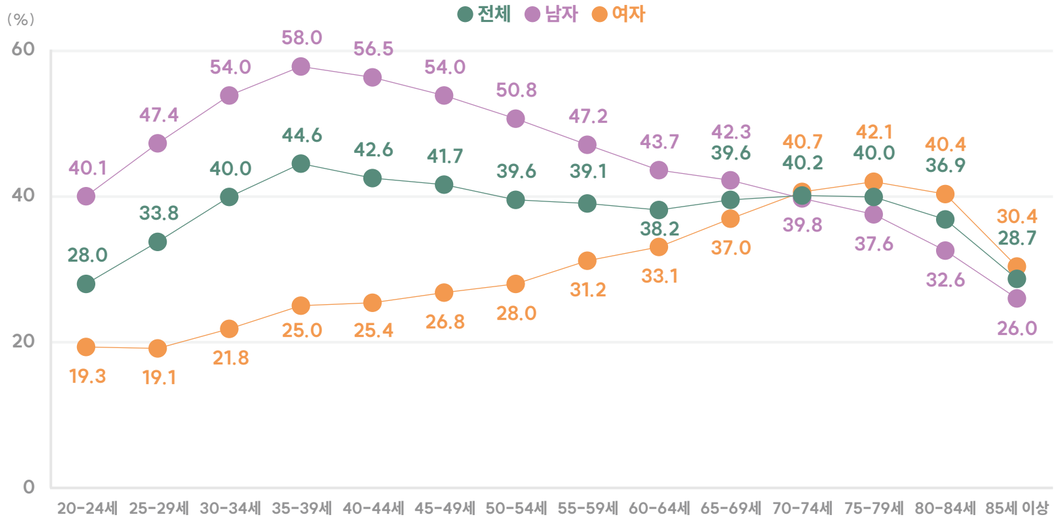
2. 성인의 비만 단계별 유병률

성, 연령별 비만 유병률
비만 단계별 유병률 (5세 연령 구간 기준)
성, 연령별 복부비만 유병률 (5세 연령 구간 기준)
성, 연령별 저체중 유병률 (5세 연령 구간 기준)

*2023년 국민건강보험공단 일반건강검진 자료를 분석함.

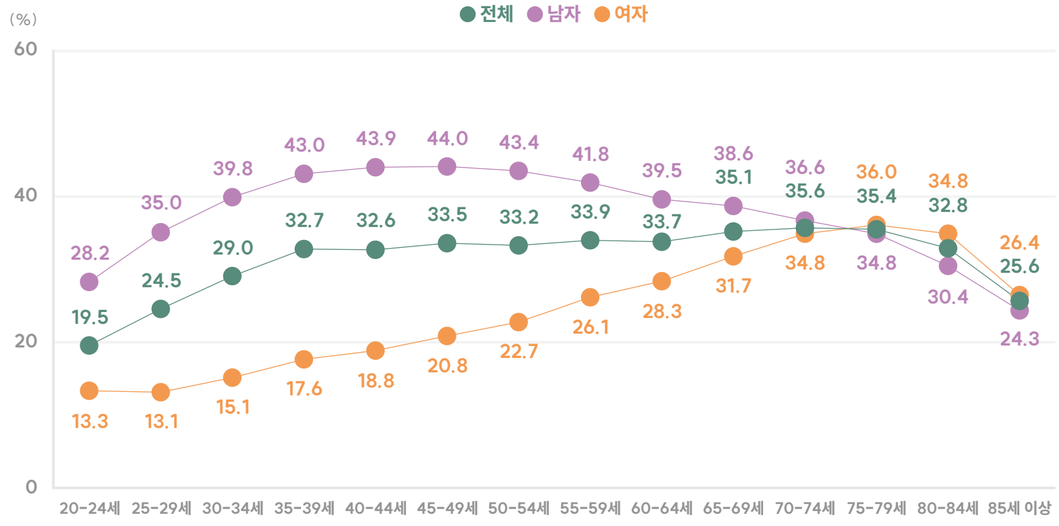
성, 연령별 비만 유병률

전체 성인의 비만 유병률은 35-39세 연령대에서 44.6%로 가장 높음.
남자는 35-39세 연령대에서 58.0%, 여자는 75-79세 연령대에서 42.1%로 비만 유병률이 가장 높음.



1단계 비만 유병률

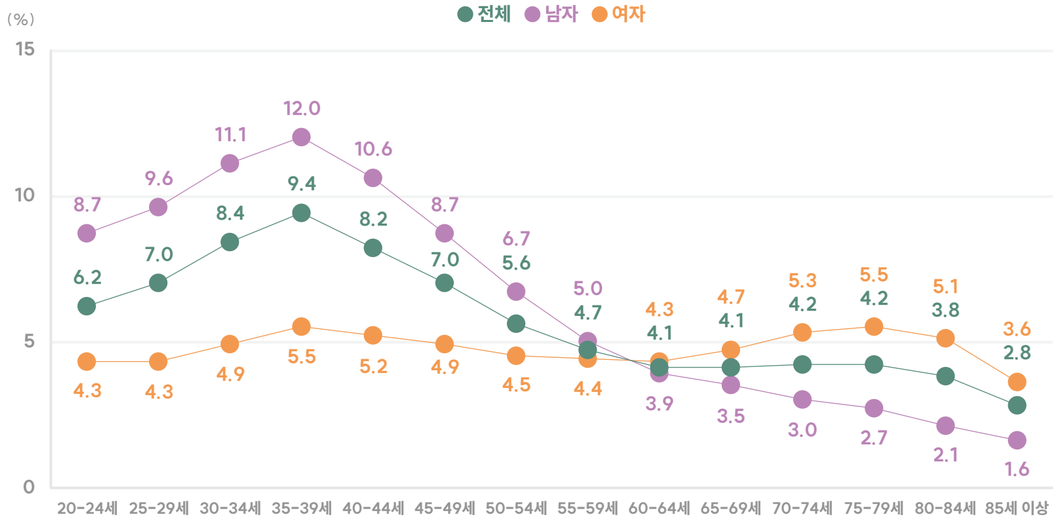
전체 성인의 1단계 비만 유병률은 70-74세 연령대에서 35.6%로 가장 높음.
남자는 45-49세 연령대에서 44.0%, 여자는 75-79세 연령대에서 36.0%로 1단계 비만 유병률이 가장 높음.



1단계 비만: 체질량지수 25-29.9 kg/m²

2단계 비만 유병률

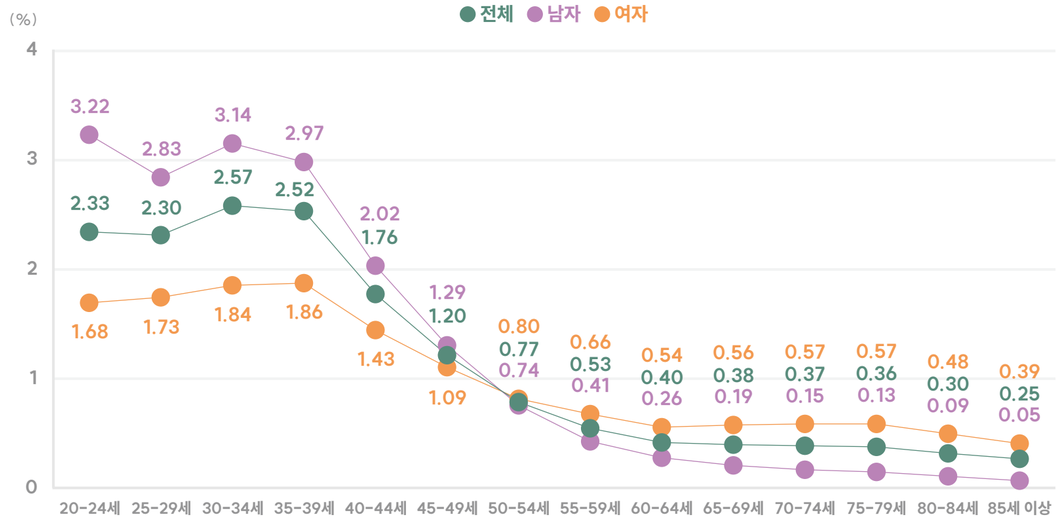
전체 성인의 2단계 비만 유병률은 35-39세 연령대에서 9.4%로 가장 높음.
남자는 35-39세 연령대에서 12.0%, 여자는 35-39세와 75-79세 연령대에서 5.5%로 2단계 비만 유병률이 가장 높음.



2단계 비만: 체질량지수 30-34.9 kg/m²

3단계 비만 유병률

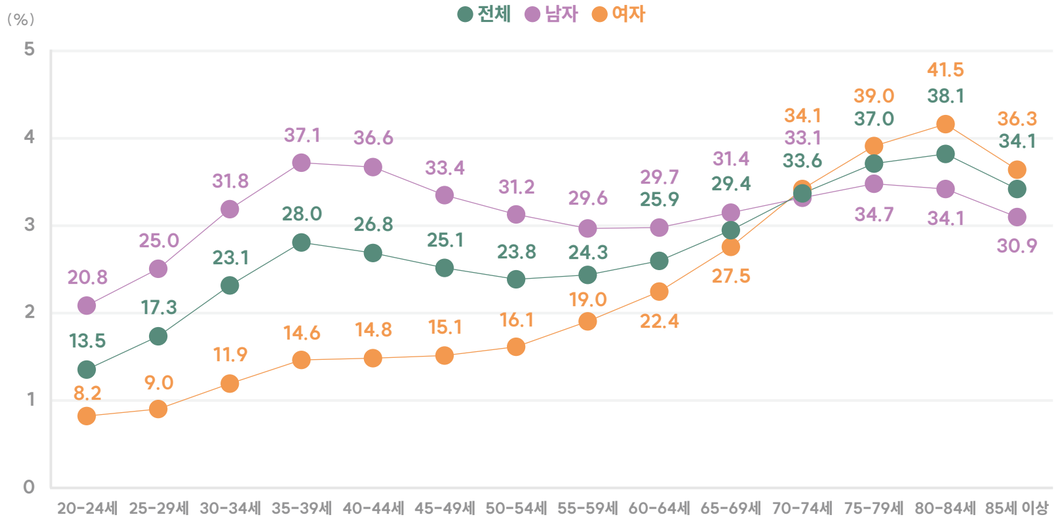
전체 성인의 3단계 비만 유병률은 30-34세 연령대에서 2.57%로 가장 높고, 이후 연령이 증가함에 따라 감소하여 60대 이후 비슷한 수준으로 유지됨.
남자는 20-24세 연령대에서 3.22%, 여자는 35-39세 연령대에서 1.86%로 3단계 비만 유병률이 가장 높음.



3단계 비만: 체질량지수 35 kg/m² 이상

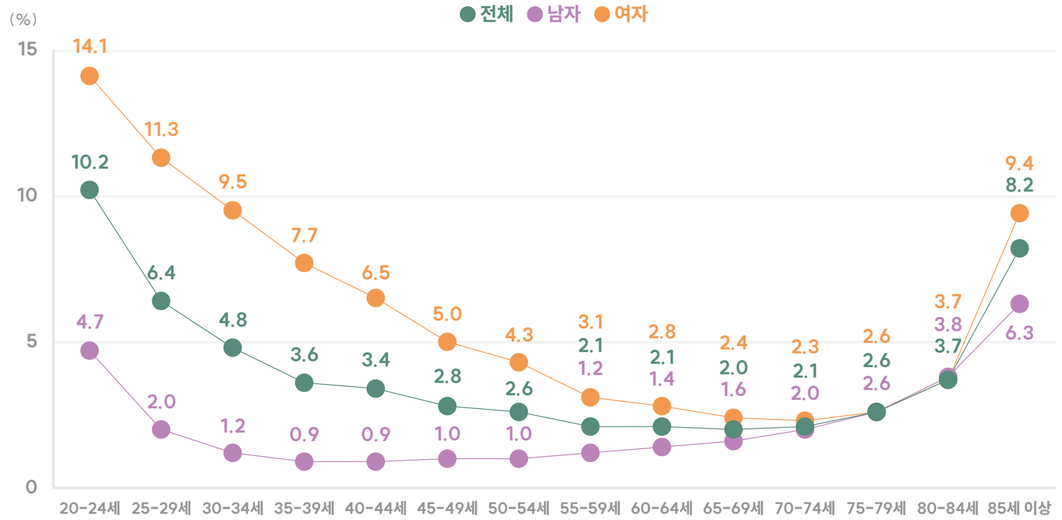
성, 연령별 복부비만 유병률

전체 성인의 복부비만 유병률은 80-84세 연령대에서 38.1%로 가장 높음.
남자의 복부비만 유병률은 35-39세 연령대에서 37.1%로 가장 높음.
여자의 복부비만 유병률은 50대부터 지속적으로 크게 증가하여 80-84세 연령대에서 가장 높음 (41.5%).



성, 연령별 저체중 유병률

전체 성인의 저체중 유병률은 20-24세 연령대에서 10.2%로 가장 높음.
남자는 85세 이상 연령대에서 6.3%, 여자는 20-24세 연령대에서 14.1%로 저체중 유병률이 가장 높음.
전체, 남자, 여자 각각 모두 연령에 따라 저체중 유병률은 U자형 패턴을 보임.



3. 비만에서 만성질환 유병률

만성질환 정의
고혈압 및 대사 질환 유병률
근골격계 질환 유병률
정신 및 수면관련 질환 유병률
만성콩팥병 유병률

*2019-2021년 질병관리청 국민건강영양조사 자료를 분석함

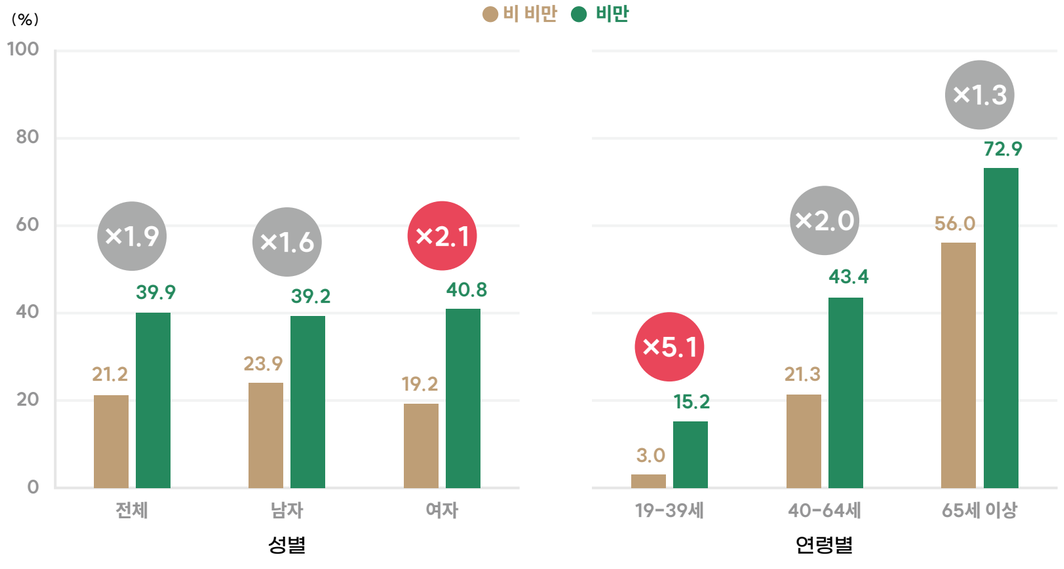
만성질환 정의

2019-2021년도 질병관리청 국민건강영양조사 자료를 분석하여 해당질환에 대한 유병상태를 다음과 같이 정의함.

고혈압	수축기혈압 ≧140 mmHg 또는 이완기혈압 ≧90 mmHg 또는 고혈압약 복용
당뇨병	공복혈당 ≧126 mg/dL 또는 당화혈색소 ≧6.5%, 당뇨병약 복용 또는 인슐린주사 투여 또는 의사진단
고콜레스테롤혈증	공복시 총콜레스테롤≧240mg/dL 또는 이상지질혈증약 복용
대사증후군	대사증후군은 아래 기준에서 세 가지 이상에 해당하는 경우로 정의함. ① 허리둘레 남자 90 cm 이상, 여자 85 cm 이상 ② 공복혈당 100 mg/dL 이상 혹은 당뇨병약 복용 혹은 인슐린 주사제 투여 ③ 혈압 130/85 mmHg 이상 혹은 고혈압약 복용 ④ 중성지방 150 mg/dL 이상 혹은 이상지질혈증약 복용 ⑤ 고밀도지단백콜레스테롤 남자 40 mg/dL 미만, 여자 50 mg/dL 미만 혹은 이상지질혈증약 복용
고요산혈증	요산 남자 7.0mg/dL 이상, 여자 6.0mg/dL 이상
골관절염	해당 질환으로 의사진단을 받은 경우
골다공증	해당 질환으로 의사진단을 받은 경우
우울증	해당 질환으로 의사진단을 받은 경우
폐쇄성 수면무호흡증	폐쇄성 수면무호흡증 선별도구 STOP-Bang의 8개 항목 중 5개 이상을 만족하는 경우로 정의함.
만성콩팥병	Chronic kidney disease-epidemiology collaboration(EPI) 로 추정한 사구체여과율 < 60 mL/min/1.73m^2 로 정의함.

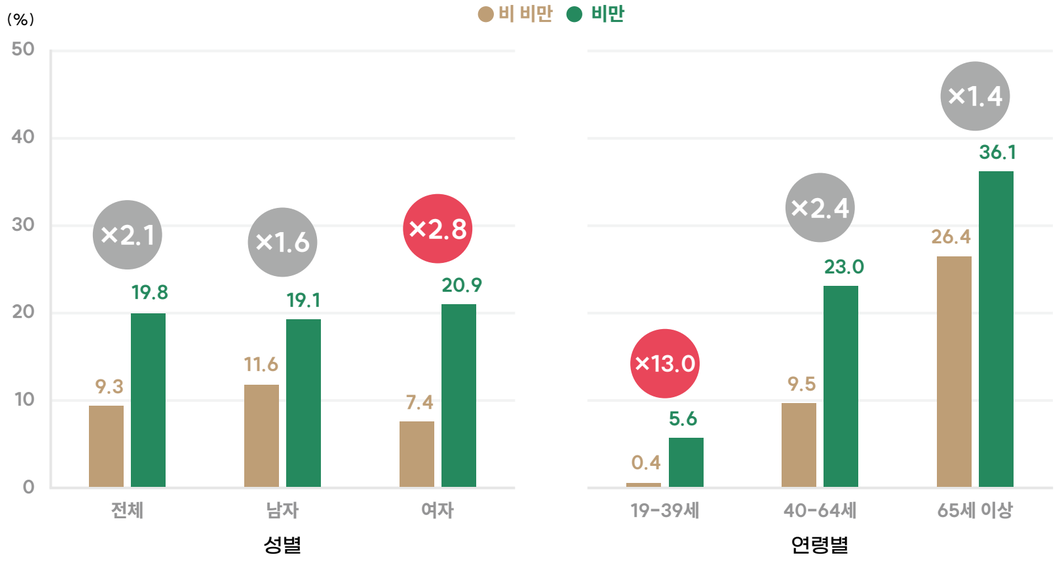
고혈압 유병률

고혈압 유병률은 비만인 경우 비만이 아닌 경우(비 비만군)보다 1.9배 높음.
비만한 남자에서 39.2%, 비만한 여자에서 40.8%의 고혈압 유병률을 보임.
젊은 연령일수록 비 비만군에 비해 비만에서의 고혈압 유병률이 뚜렷하게 높음.



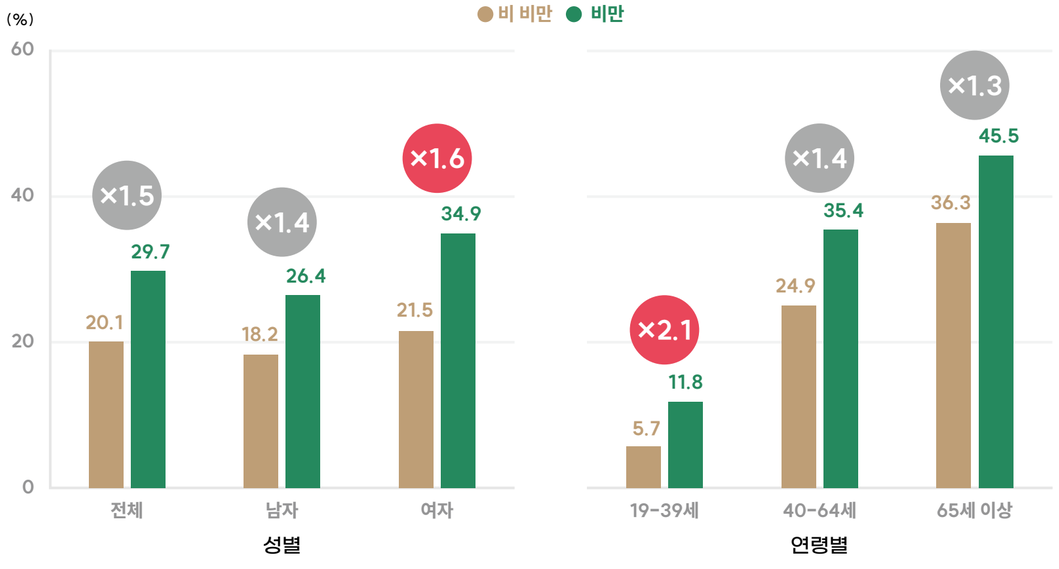
당뇨병 유병률

당뇨병 유병률은 비만인 경우 비만이 아닌 경우(비 비만군)보다 2.1배 높음.
비만한 남자에서 19.1%, 비만한 여자에서 20.9%의 당뇨병 유병률을 보임.
젊은 연령일수록 비 비만군에 비해 비만에서의 당뇨병 유병률이 뚜렷하게 높음.



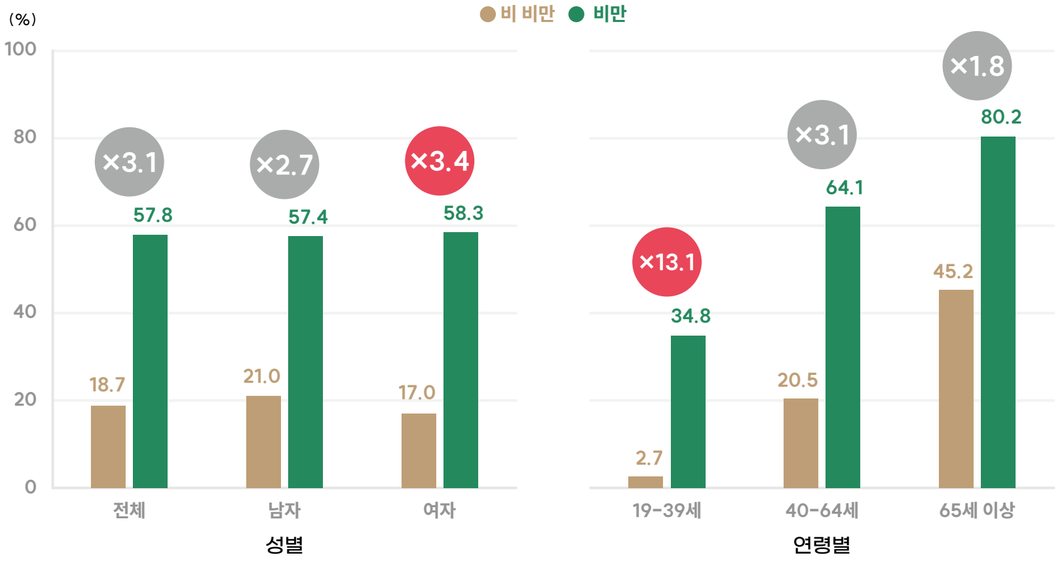
고콜레스테롤혈증 유병률

고콜레스테롤혈증 유병률은 비만인 경우 비만이 아닌 경우(비 비만군)보다 1.5배 높음.
비만한 남자에서 26.4%, 비만한 여자에서 34.9%의 고콜레스테롤혈증 유병률을 보임.
젊은 연령일수록 비 비만군에 비해 비만에서의 고콜레스테롤혈증 유병률이 뚜렷하게 높음.



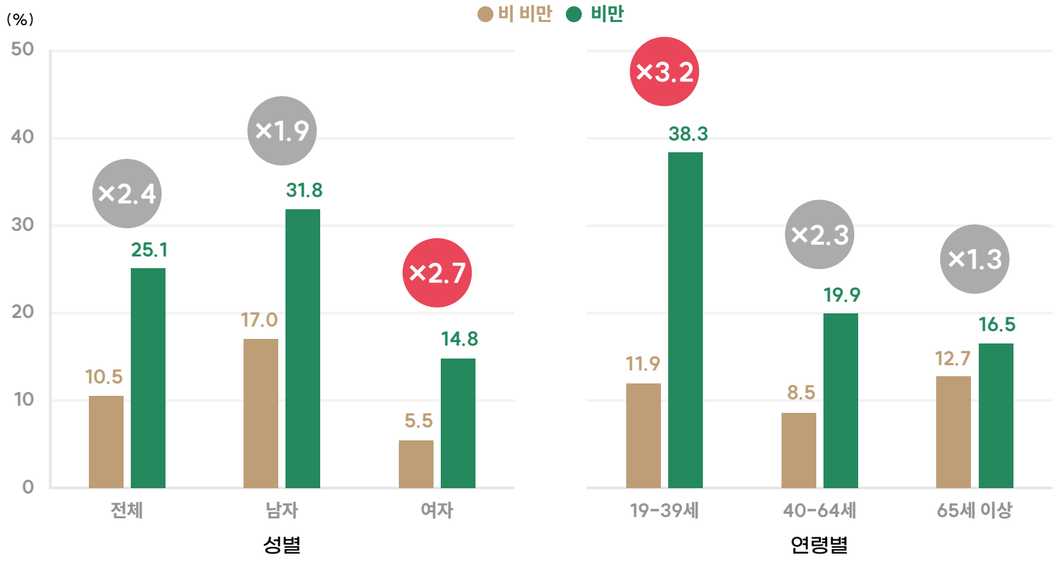
대사증후군 유병률

대사증후군 유병률은 비만인 경우 비만이 아닌 경우(비 비만군)보다 3.1배 높음.
비만한 남자에서 57.4%, 비만한 여자에서 58.3%의 대사증후군 유병률을 보임.
젊은 연령일수록 비 비만군에 비해 비만에서의 대사증후군 유병률이 뚜렷하게 높음.



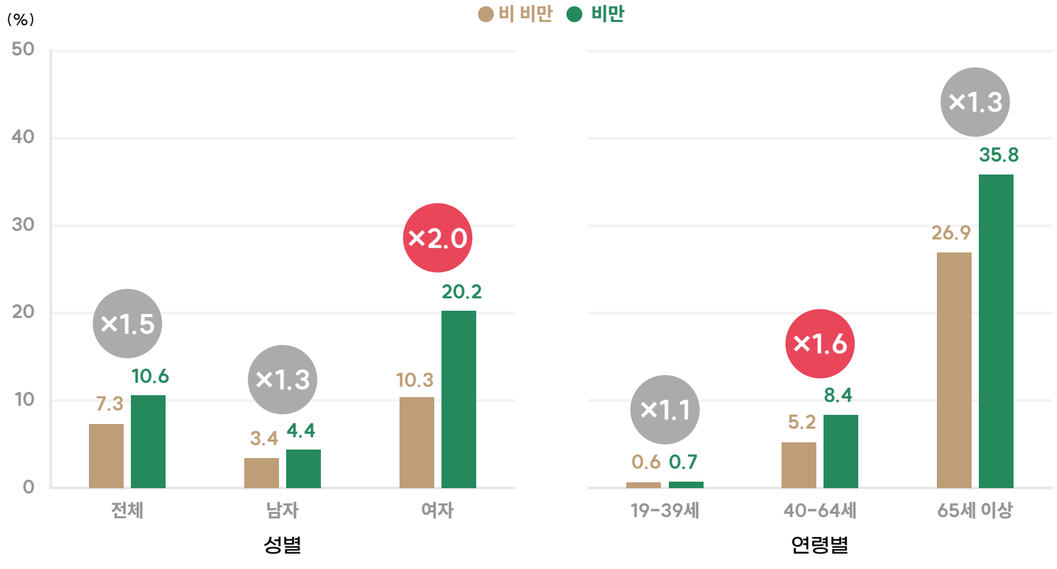
고요산혈증 유병률

고요산혈증 유병률은 비만인 경우 비만이 아닌 경우(비 비만군)보다 2.4배 높음.
비만한 남자에서 31.8%, 비만한 여자에서 14.8%의 고요산혈증 유병률을 보임.
젊은 연령일수록 비 비만군에 비해 비만에서의 고요산혈증 유병률이 뚜렷하게 높음.



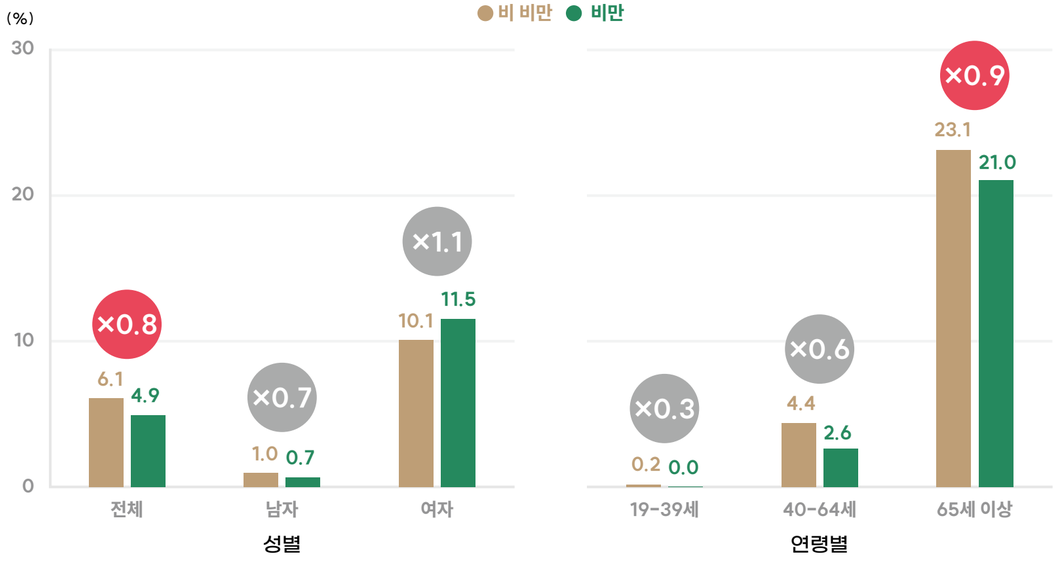
골관절염 유병률

골관절염 유병률은 비만인 경우 비만이 아닌 경우(비 비만군)보다 1.5배 높음.
비만한 남자보다 비만한 여자에서 골관절염 유병률이 뚜렷하게 높음.
비만인 경우 골관절염 유병률은 65세 이상에서 35.8%로 가장 높음.



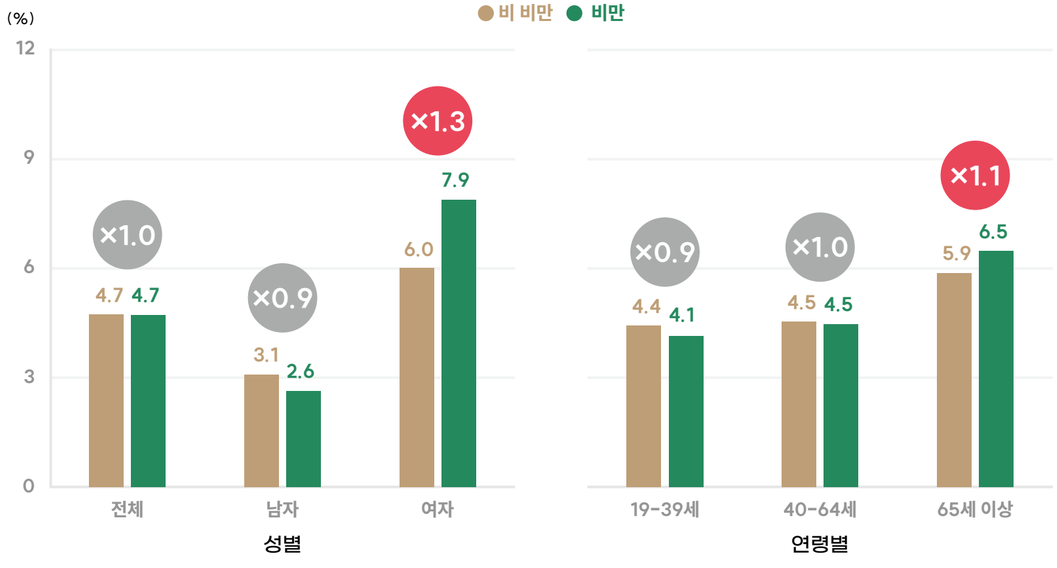
골다공증 유병률

골다공증 유병률은 비만인 경우가 비만이 아닌 경우(비 비만군)보다 낮음.
모든 연령대에서 비만인 경우 비 비만군보다 골다공증 유병률이 낮음.



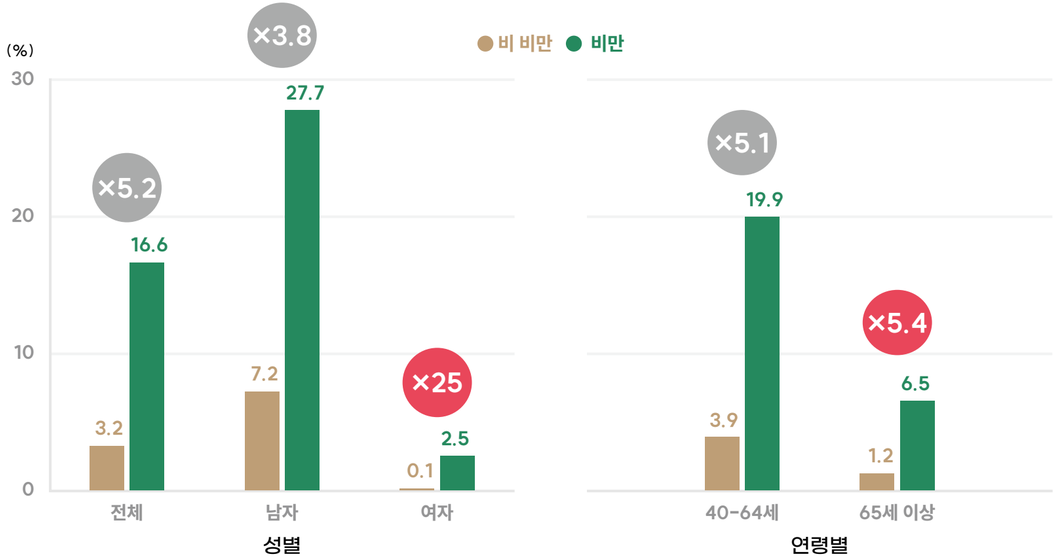
우울증 유병률

우울증 유병률은 비만인 경우와 비만이 아닌 경우(비 비만군)가 비슷함.
여자에서 비만인 경우 우울증 유병률 7.9%로 비 비만군보다 높음.



폐쇄성 수면무호흡증 유병률

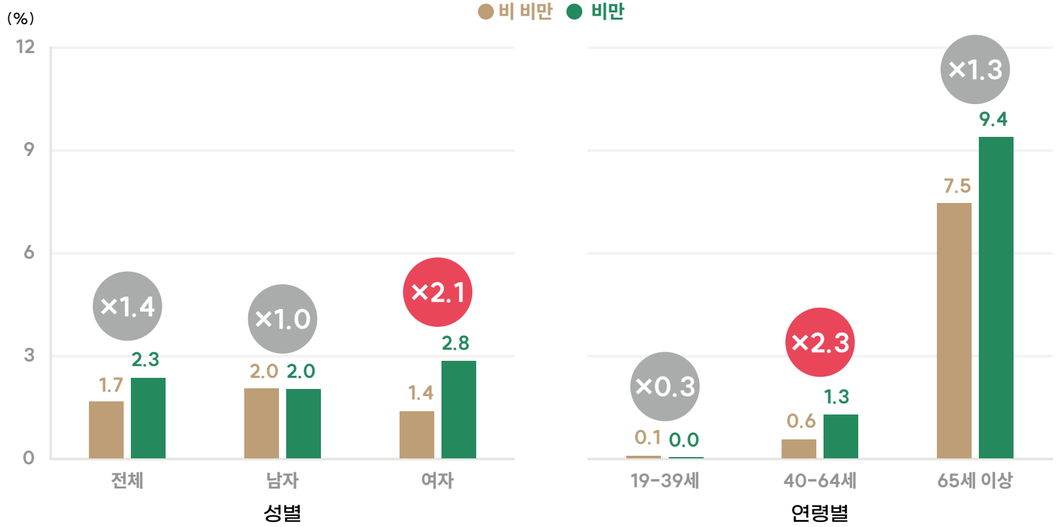
폐쇄성 수면무호흡증 유병률은 비만인 경우 비만이 아닌 경우(비 비만군)보다 5.2배 높음.
비만한 남자에서 27.7%, 비만한 여자에서 2.5%의 폐쇄성 수면무호흡증 유병률을 보임.



폐쇄성 수면무호흡증은 40세 이상에서만 조사됨.

만성콩팥병 유병률

만성콩팥병 유병률은 비만인 경우 비만이 아닌 경우(비 비만군)보다 1.4배 높음.
비만한 여자에서 비 비만군에 비해 만성콩팥병의 유병률이 2.1배 높음.
40대 이상에서 비만인 경우 비 비만군에 비해 만성콩팥병의 유병률이 높음.



4. 최근 10년간 (2014-2023년) 소아청소년 과체중 및 비만 유병률

소아청소년 과체중 및 비만 유병률

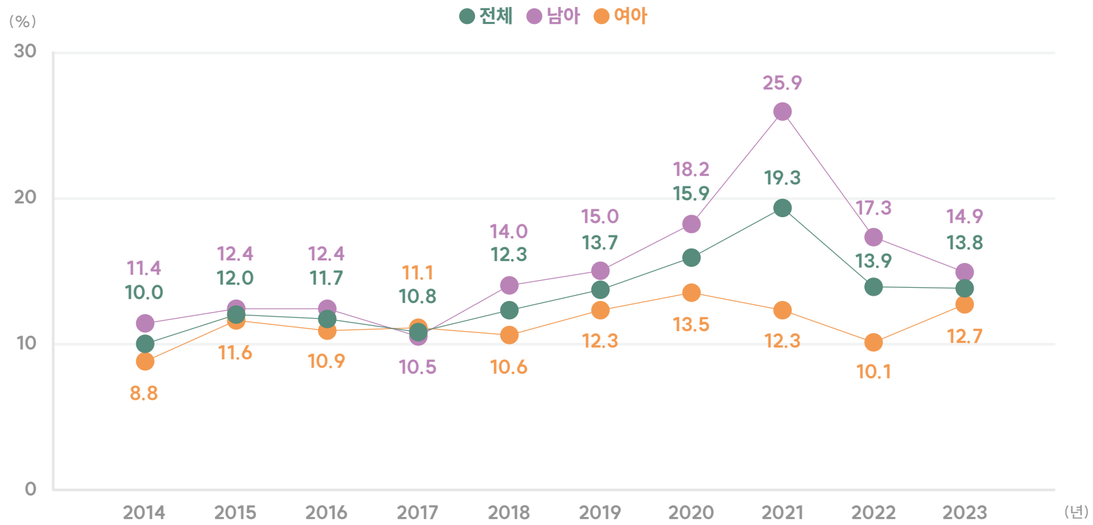
소아청소년 연령별 비만 유병률

성별에 따른 소아청소년 1세 단위 과체중 및 비만 유병률

*2014-2023년 질병관리청 국민건강영양조사 자료를 분석함.

최근 10년간 소아청소년 비만 유병률

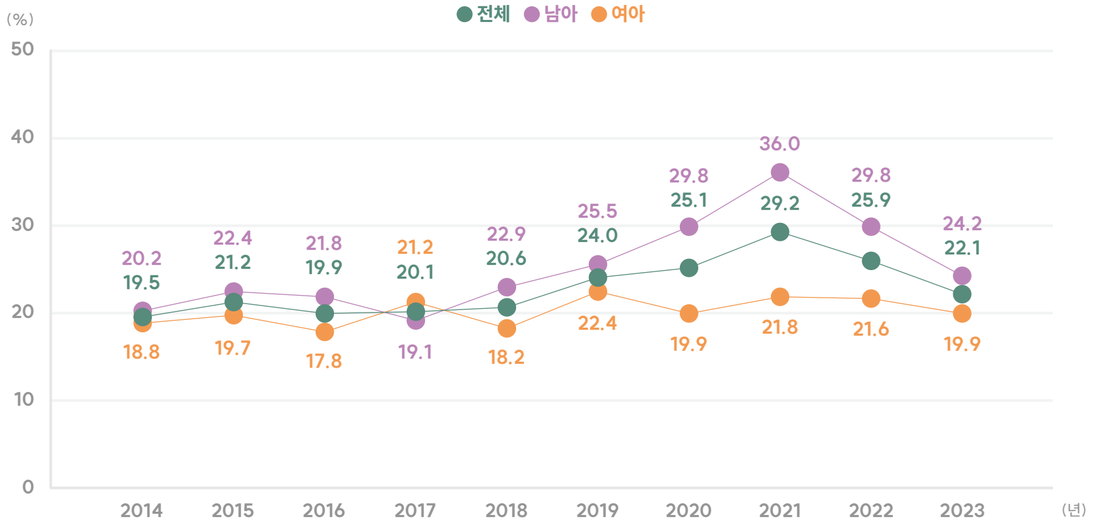
전체 소아청소년의 비만 유병률은 증가 추세를 보이다가, 2021년 이후로 감소 추세를 보임.
2023년 비만 유병률은 13.8%로 코로나19 유행 직전인 2019년과 비슷한 수준을 보였음.
남아는 2021년 이후 지속적 감소 추세를 보였고, 여아에서는 2020년 이후 감소 추세를 보이다가 2023년 12.7%로 증가함.



소아청소년 비만: 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 성, 연령별 체질량지수 백분위수를 사용하여 체질량지수 95백분위수 이상으로 정의함.

최근 10년간 소아청소년 과체중 및 비만 유병률

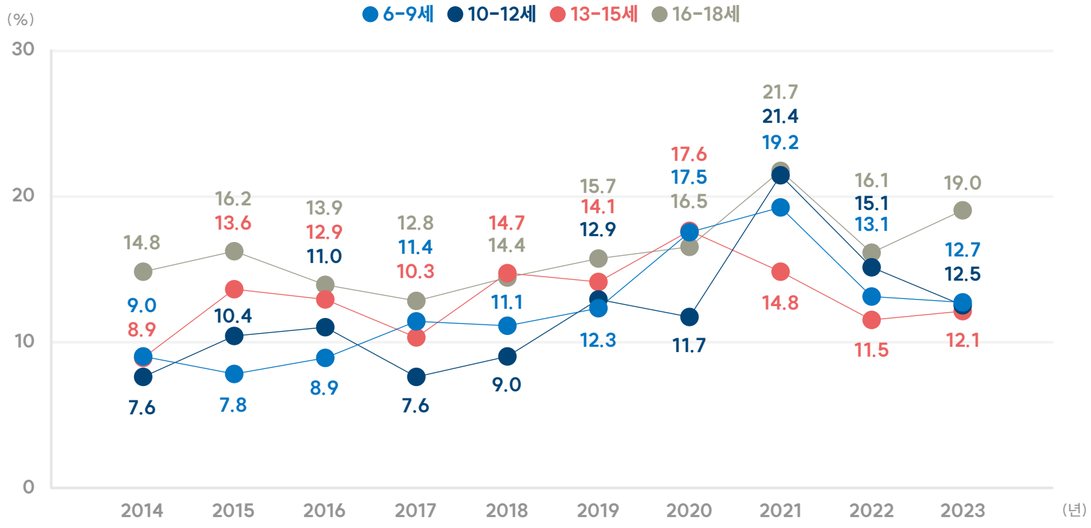
전체 소아청소년의 과체중 및 비만 유병률은 증가 추세를 보이다가, 2021년 이후로 감소 추세를 보임. (2023년 22.1%)
남아, 여아 모두에서 2021년 이후 감소 추세를 보임. (2023년 남아 24.2%, 여아 19.9%)



소아청소년 과체중 및 비만: 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 성, 연령별 체질량지수 백분위수를 사용하여 체질량지수 85백분위수 이상으로 정의함.

최근 10년간 소아청소년 연령별 비만 유병률

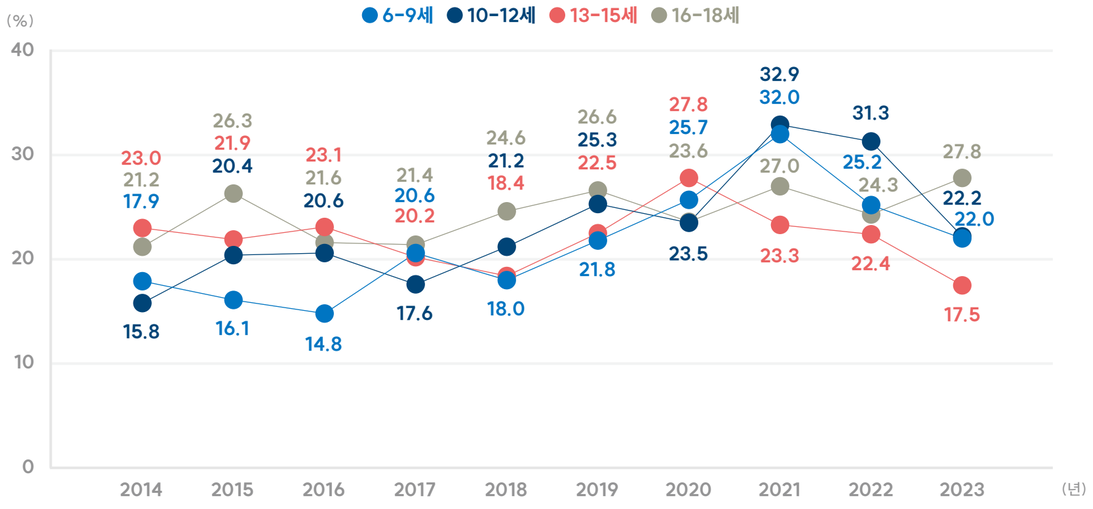
10년 전과 비교하여 모든 연령대에서 소아청소년의 비만 유병률은 증가함.
6-9세, 10-12세의 비만 유병률은 2021년 급증 이후 감소 추세를 보임.



소아청소년 비만: 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 성, 연령별 체질량지수 백분위수를 사용하여 체질량지수 95백분위수 이상으로 정의함.

최근 10년간 소아청소년 연령별 과체중 및 비만 유병률

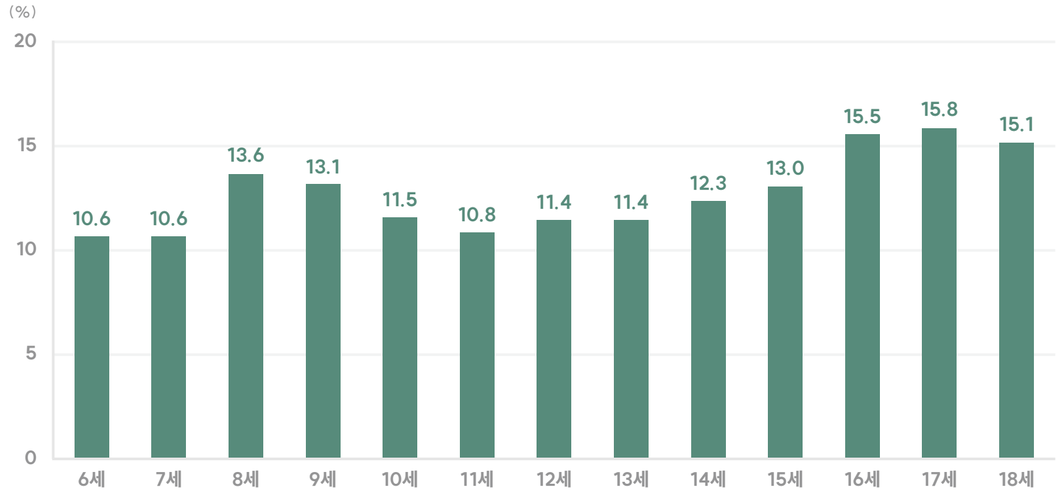
10년 전과 비교하여 대부분의 연령대에서 소아청소년의 과체중 및 비만 유병률은 증가하였으나, 13-15세의 경우 감소함.
2023년 소아청소년의 과체중 및 비만 유병률은 16-18세에서 27.8%로 가장 높음.



소아청소년 과체중 및 비만: 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 성, 연령별 체질량지수 백분위수를 사용하여 체질량지수 85백분위수 이상으로 정의함.

소아청소년 1세 단위 비만 유병률

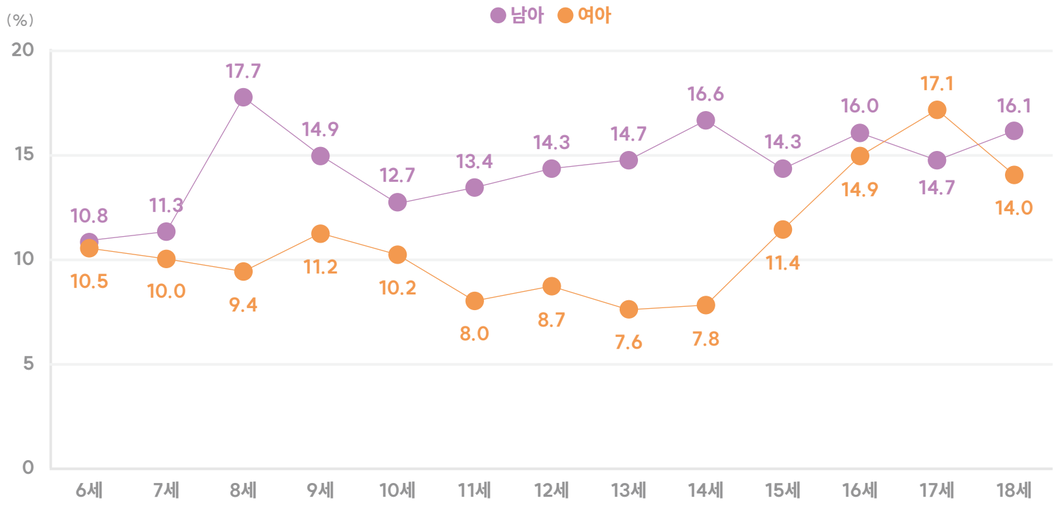
소아청소년의 비만 유병률은 17세에서 15.8%로 가장 높음.



소아청소년 비만: 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 성, 연령별 체질량지수 백분위수를 사용하여 체질량지수 95백분위수 이상으로 정의함.
2022-2023년 질병관리청 국민건강영양조사 자료를 분석함.

성별에 따른 소아청소년 1세 단위 비만 유병률

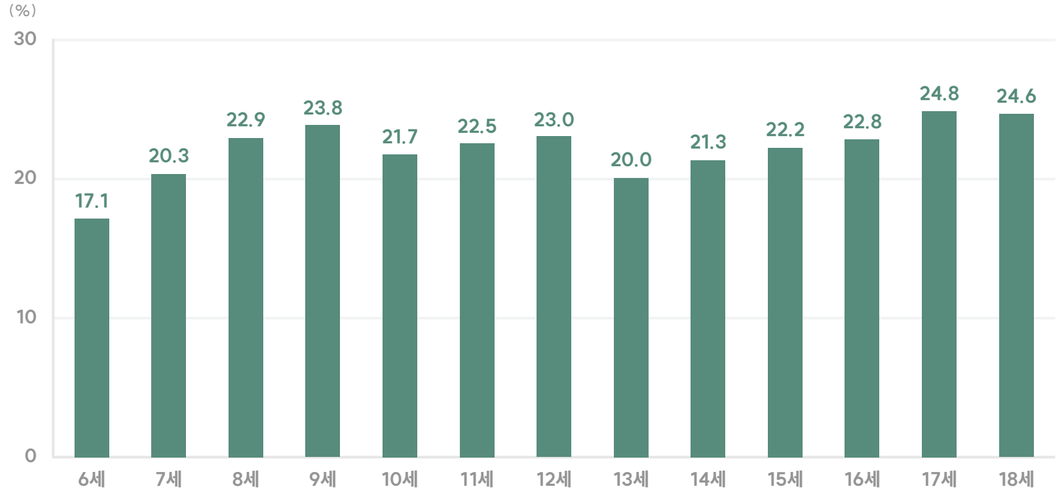
남아에서의 비만 유병률은 8세에 17.7%로 가장 높고 이후 약간 감소 후 다시 증가하는 추세를 보임.
여아에서의 비만 유병률은 16세부터 증가하여 17세에 17.1%로 가장 높음.



소아청소년 비만: 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 성, 연령별 체질량지수 백분위수를 사용하여 체질량지수 95백분위수 이상으로 정의함.
2022-2023년 질병관리청 국민건강영양조사 자료를 분석함.

소아청소년 1세 단위 과체중 및 비만 유병률

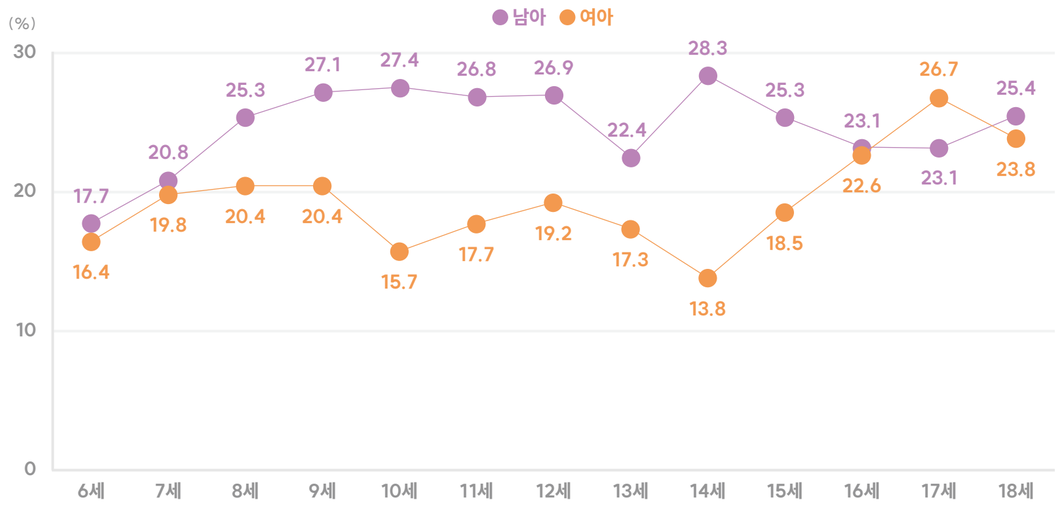
전체 소아청소년의 과체중 및 비만 유병률은 17세에서 24.8%로 가장 높음.



소아청소년 과체중 및 비만: 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 성, 연령별 체질량지수 백분위수를 사용하여 체질량지수 85백분위수 이상으로 정의함.
2022-2023년 질병관리청 국민건강영양조사 자료를 분석함.

성별에 따른 소아청소년 1세 단위 과체중 및 비만 유병률

남아에서의 과체중 및 비만 유병률은 8세부터 증가하여 14세에 28.3%로 가장 높음.
여아에서의 과체중 및 비만 유병률은 16세부터 증가하여 17세에 26.7%로 가장 높음.



소아청소년 과체중 및 비만: 2017년 소아청소년 성장도표를 기준으로 성, 연령별 체질량지수 백분위수를 사용하여 체질량지수 85백분위수 이상으로 정의함.
2022-2023년 질병관리청 국민건강영양조사 자료를 분석함.

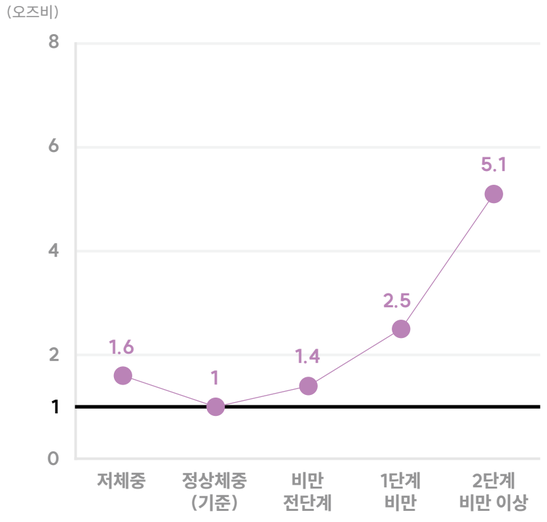
5. 부모의 비만과 자녀의 비만

부모 체질량 지수와 자녀의 비만
부모의 비만과 자녀의 비만
자녀 구성 유형과 자녀의 비만 유병률

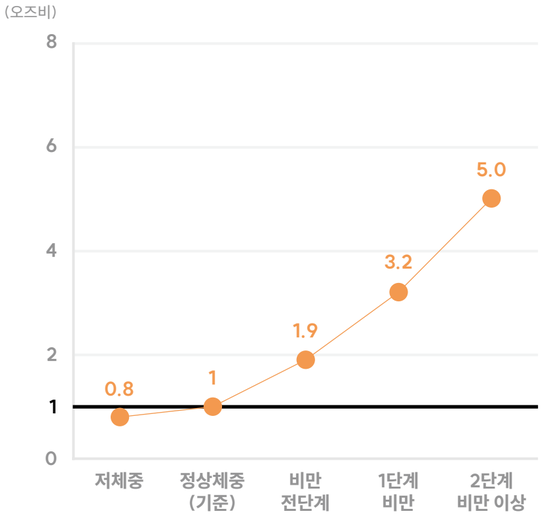
*2014-2023년 질병관리청 국민건강영양조사 자료를 분석함.

부모 체질량 지수와 자녀의 비만

부모의 체질량 지수가 높을수록 자녀가 비만일 확률은 증가함.
아버지나 어머니가 2단계 비만 이상일 때 자녀가 비만할 확률은 5배 이상 증가함.



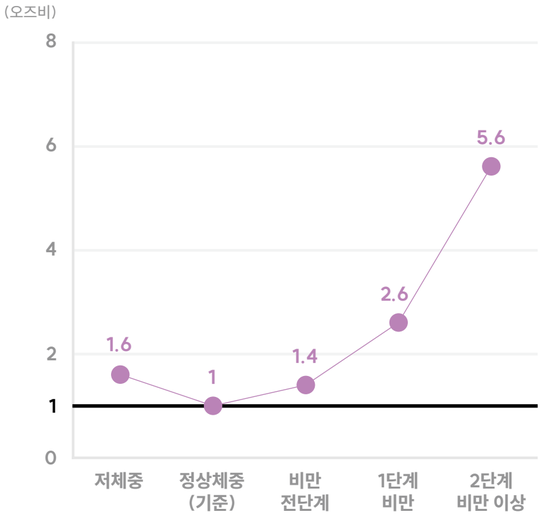
아버지 체질량 지수와 자녀 비만



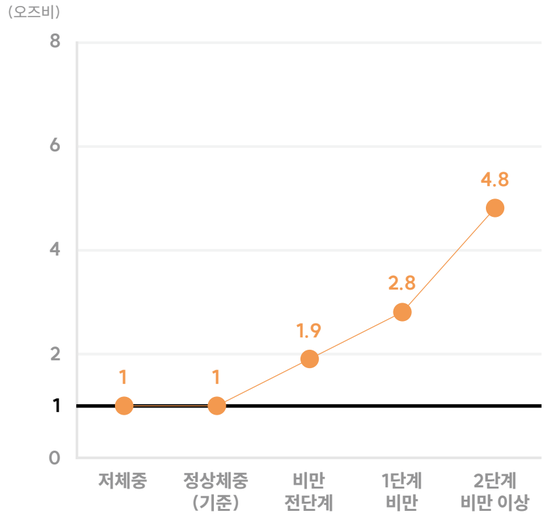
어머니 체질량 지수와 자녀 비만

남아에서 부모 체질량 지수와 자녀의 비만

남아의 비만은 아버지의 비만에 더 영향을 많이 받고,아버지가 2단계 비만 이상일 경우 남아의 비만은 5.6배 증가함.



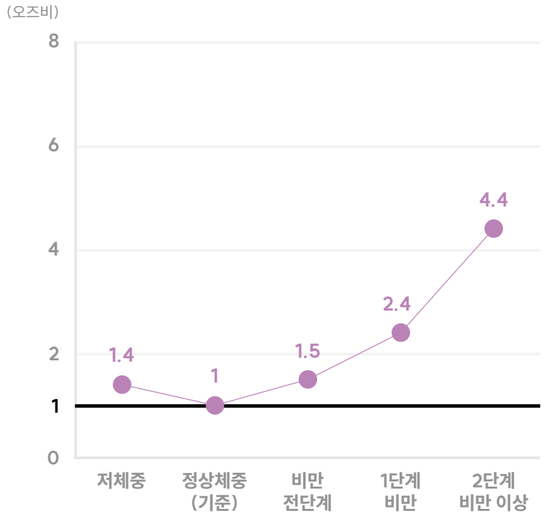
아버지 체질량 지수와 자녀 비만



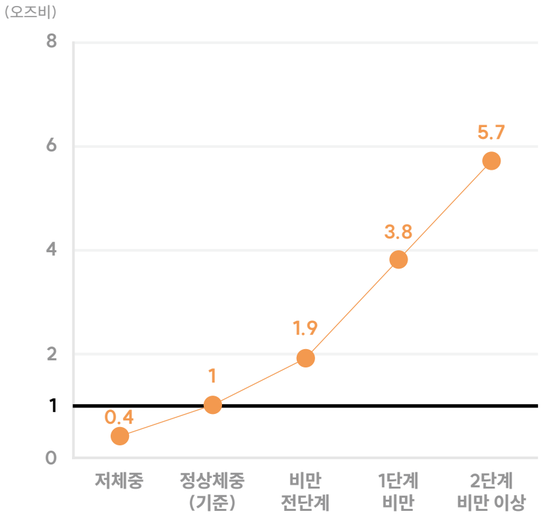
어머니 체질량 지수와 자녀 비만

여아에서 부모 체질량 지수와 자녀의 비만

여아의 비만은 어머니의 비만에 더 영향을 많이 받고, 어머니가 2단계 비만 이상일 경우 여아의 비만은 5.7배 증가함.



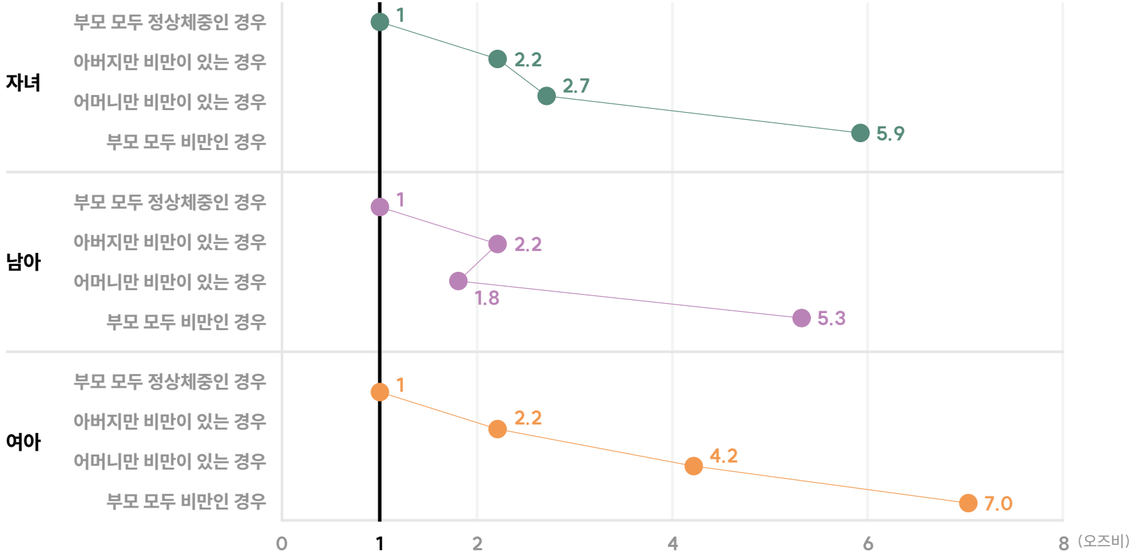
아버지 체질량 지수와 자녀 비만



어머니 체질량 지수와 자녀 비만

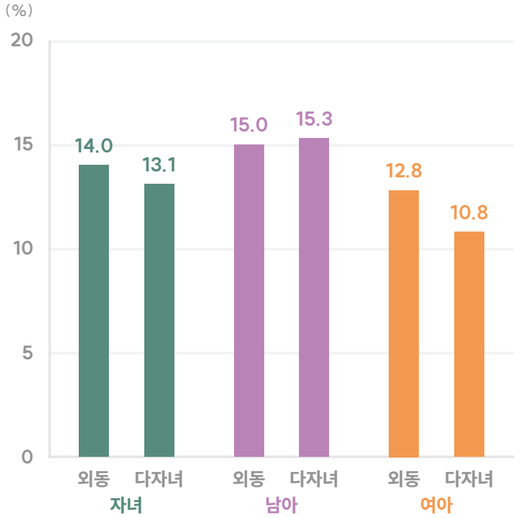
부모의 비만과 자녀의 비만

자녀의 비만은 아버지의 비만(2.2배)보다 어머니의 비만(2.7배)에 더 큰 영향을 받음.
부모 모두 비만일 경우 자녀의 비만은 5.9배 증가함.
부모 모두 비만일 경우 남아의 비만은 5.3배, 여아의 비만은 7.0배로 급격히 증가함.



자녀 구성 유형과 자녀의 비만 유병률

외동의 비만 유병률(14.0%)이 다자녀의 비만 유병률(13.1%)보다 높음.
첫째 자녀의 비만 유병률(15.1%)이 둘째 이상인 자녀의 비만 유병률(11.0%)보다 높음.



자녀 구성 유형과 비만 유병률

다자녀 출생 순위와 비만 유병률

대한비만학회 이사진

회장	서영성	계명대학교 동산병원 가정의학과
부회장	강지현	건양의대 건양대병원 가정의학과
	정소정	건국의대 건국대병원 소아청소년과
	김기우	연세대 치과대학 구강생물학교실
	임정현	서울대병원 급식영양과
이사장	김민선	울산의대 서울아산병원 내분비내과
총무위원회 / 이사	이재혁	명지병원 내분비내과
학술위원회 / 이사	최성희	서울의대 분당서울대병원 내분비내과
편집위원회 / 이사	이은정	성균관의대 강북삼성병원 내분비내과
수련위원회 / 이사	이승환	가톨릭의대 서울성모병원 내분비내과
연구(임상)위원회 / 이사	이상열	경희의대 경희대병원내분비대사내과
연구(기초)위원회 / 이사	최형진	서울의대 해부학교실
교육위원회 / 이사	김정환	을지의대 강남을지병원 가정의학과
언론-홍보위원회 / 이사	허양임	차의과대 분당차병원 가정의학과
기획위원회 / 이사	조은희	강원의대 강원대병원 내분비내과
대외협력정책(대외협력)위원회 / 이사	김상용	조선의대 조선대병원 내분비대사내과
대외협력정책(정책)위원회 / 이사	박정환	한양의대 한양대병원 내분비대사내과
재무위원회 / 이사	권혁상	가톨릭의대 여의도성모병원 내분비내과

정보위원회 / 이사	한병덕	고려의대 안암병원 가정의학과
국제협력위원회 / 이사	정창희	울산의대 서울아산병원 내분비내과
개원위원회 / 이사	이창현	서울행복내과
보험법제위원회 / 이사	남가은	고려의대 구로병원 가정의학과
IT융합 대사증후군 치료위원회 / 이사	손장원	가톨릭의대 부천성모병원 내분비내과
진료지침위원회 / 이사	윤영숙	인제의대 일산백병원 가정의학과
식품영양위원회 / 이사	김오연	동아대 식품영양학과
운동위원회 / 이사	이소정	경희대 체육대학원 스포츠의과학
행동치료위원회 / 이사	김율리	인제의대 일산백병원 정신건강의학과
비만대사수술위원회 / 이사	손상용	아주의대 아주대병원 외과
소아청소년위원회 / 이사	홍용희	순천향의대 순천향대부천병원 소아청소년과
빅데이터위원회 / 이사	한경도	숭실대 정보통계보험수리학과
고시위원회 / 이사	김양현	고려의대 안암병원 가정의학과
윤리위원회 / 이사	이지원	연세의대 세브란스병원 가정의학과
무임소 / 이사	홍상모	한양의대 구리병원 내분비대사내과
감사	송욱	서울대 체육교육과
	신혜정	국립중앙의료원 소아청소년과

비만 팩트시트 10년 주요 연혁 (2015-2024)

2015
- 팩트시트 첫 발간 국내 최초의 비만 통계 보고서인 '비만 팩트시트' 를 발간함
- 비만 및 복부비만 유병률 비만 및 복부비만율, 비만을 유발하는 생활습관, 비만으로 인한 동반질환 문제를 조명함

2016
- 비만과 심뇌혈관질환 및 주요 만성질환 비만할 경우 심근경색 및 뇌졸중, 당뇨병, 고혈압, 고지혈증 유병률이 높았음
- 지역별 비만 유병률 지역별 비만 및 복부비만율을 비교함

2017
- 비만과 사회경제적 요인 사회경제적 수준과 가구형태(1인가구)에서의 비만 문제를 확인하고 사회적 요소에 대한 관심이 필요함은 강조함
- 비만과 여성 건강 비만에서 불규칙 월경이 더 흔하며, 자간증, 고위험 임신과 같은 모성 합병증 증가함

2018
- 허리둘레와 총사망 총사망률은 허리둘레와 U-자형 관계를 보임
- 허리둘레와 심뇌혈관질환 및 암 발생 허리둘레가 클수록 당뇨병, 고혈압, 심근경색, 허혈성뇌졸중, 암 발생률은 증가함

2019
- 청년(20-39세) 비만과 건강위험 청년 비만에서는 동반질환 발생 위험이 급격히 증가함을 확인하고 청년 비만의 심각성을 강조함
- 사회경제적 상태와 비만 교육수준과 가구소득이 낮을수록 비만 및 복부비만 유병률이 높아져 비만의 건강 불평등 측면을 강조함

2020
- 비만 단계별 유병률 제시 단계별 비만 유병률을 처음으로 제시함: 1단계 32.5%, 2단계 5.2%, 3단계 0.81% (2018년)
- 중장년층과 노년층의 비만 및 복부비만 유병률 중장년층에 비해 노년층의 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 심근경색, 뇌졸중, 암 유병률이 높았음

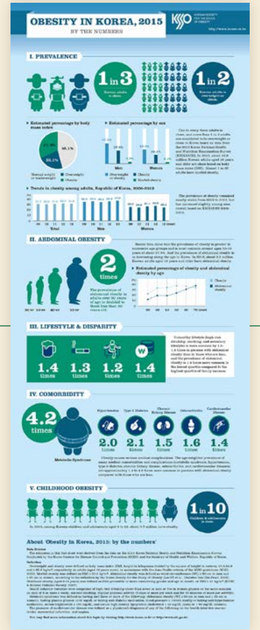
2021
- 비만과 동반질환 비만에서 당뇨병 2.6배, 심근경색 1.3배, 뇌졸중 1.2배, 암 1.2-1.5배 높은 발생률을 보임
- 생애전환기 당뇨병/심뇌혈관질환 위험도 40세, 66세 생애전환기의 비만과 당뇨병 및 심뇌혈관질환 위험도를 확인하였음

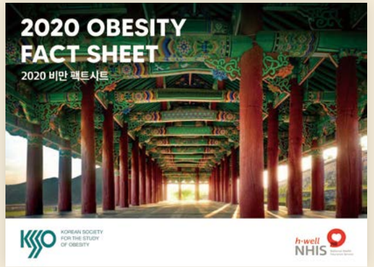
2022
- 비만과 기대여명 및 건강수명 남녀 모두 정상체중에 비해 비만도가 증가함에 따른 건강수명의 손실정도가 큼
- 비만과 유전적 특징 기존에 비만과의 연관성이 높게 알려진 FTO, GIPR 외에 ADCT3, MUSTN1를 포함하여 새로운 다양한 유전적 변이를 확인함

2023
- 소아청소년 비만 및 복부비만 유병률 10년간 (2012~2021년) 비만 및 복부비만 유병률은 2-3배 이상 급증하였음을 확인하고 소아청소년 비만 문제의 심각성을 인지하고 개입의 필요성을 부각하였음
- 비만대사수술 현황 2019년부터 비만대사수술 건강보험 적용이 되면서 매년 평균 2297명의 환자가 비만대사수술을 받았음

2024
- 비만 단계별 사망 및 동반질환 발생 위험 모든 연령대에서 비만 단계가 높아질수록 만성질환 발생 위험 증가
- 2022년 생체전기저항측정법(BIA) 체성분검사 체성분분석 자료를 활용하여 체지방률, 근감소 기준을 사용한 비만 현황을 평가하였음
- 최근 10년간 대사증후군 유병률 최근 10년간 전체 성인의 대사증후군 유병률은 2013년 23.3%에서 2022년 28.6%로 1.12배 증가

비만 팩트시트 표지 아카이브 (2015-2024)





비만 팩트시트 기반 연구

2023 Obesity Fact Sheet: Prevalence of Obesity and Abdominal Obesity in Adults, Adolescents, and Children in Korea from 2012 to 2021

Journal of Obesity & Metabolic Syndrome 2024;33:27-35

인용횟수 **54**

Obesity Fact Sheet in Korea, 2021: Trends in Obesity Prevalence and Obesity-Related Comorbidity Incidence Stratified by Age from 2009 to 2019

J Obes Metab Syndr 2022; 31(2): 169-177

인용횟수 **128**

Obesity Fact Sheet in Korea, 2020: Prevalence of Obesity by Obesity Class from 2009 to 2018

J Obes Metab Syndr 2021; 30(2): 141-148

인용횟수 **91**

Obesity Fact Sheet in Korea, 2019: Prevalence of Obesity and Abdominal Obesity from 2009 to 2018 and Social Factors

J Obes Metab Syndr 2020; 29(2): 124-132

인용횟수 **106**

Obesity Fact Sheet in Korea, 2018: Data Focusing on Waist Circumference and Obesity-Related Comorbidities

J Obes Metab Syndr 2019; 28(4): 236-245

인용횟수 **36**

비만 팩트시트 10주년을 축하하며

비만팩트시트 10주년을 진심으로 축하드립니다.
처음 비만팩트시트 만들면서 어떤 자료를
어떻게 표현할 지 고민했던 것이 엊그제
같은데 벌써 10주년이라니 세월이 빠른 것
같습니다. 앞으로도 비만예방과 관리를 위한 좋은
자료로 국민건강증진에 이바지 해주시길 기대합니다.

권혁상
가톨릭의대 여의도성모병원 내분비내과

대한비만학회가 발간하는 「비만 팩트시트」의 10주년을
진심으로 축하드립니다. 지난 10년간 「비만 팩트시트」는
과학적인 분석을 통하여 우리나라 비만에 관한 다양한
통계 자료를 국민들에게 제공해 왔습니다. 앞으로도
「비만 팩트시트」가 비만에 관한 인식 제고와 비만 극복을
하기 위한 동반자로서 더욱 발전하길 기대합니다.

김민선
울산의대 서울아산병원 내분비내과

2015년 공덕동에 있는 공단에
유순집 이사장님 그리고 이원영 이사님
모시고 회의 했던 게 엊그제 같습니다.
팩트시트의 큰 획을 그은 만큼 더 큰
발전이 있기를 바랍니다.

김양현
고대안암병원 가정의학과

비만팩트시트 발간 10주년을 진심으로 축하드립니다.
지난 10년동안 팩트시트는 우리나라 비만의 실태를
알리고 정책과 인식 개선에 많은 기여를 많이 했습니다.
이를 위해 지금까지 준비해주신 빅데이터위원회
이사님과 위원님들의 헌신과 노고에 감사드립니다.

김성수
충남의대 충남대병원 가정의학과

10주년 기념 10th

비만팩트시트 발행 10주년을 진심으로 축하드립니다.
세상에서 가장 어려운 일 중 하나는 '지속적으로, 꾸준하게' 무언가를
이어가는 일이라고 합니다. 대한비만학회 비만빅데이터위원회는 지난
10년간 사명감을 가지고 우리나라 비만 관련 각종 지표를 체계적으로
발굴하고, 이를 바탕으로 기준치를 마련해 주셨습니다. 그 노고와 헌신에
깊이 감사드리며, 그간 축적된 자료는 국민 건강 증진과 비만 정책 수립에
더욱 큰 밑거름이 될 것입니다. 앞으로도 변함없는 전문성과 열정으로
국민의 건강한 미래를 이끄는 든든한 길잡이가 되어주시기를 바랍니다.

서영성
계명대학교 동산의료원 가정의학과

대한비만학회 「비만팩트시트」 발간 10주년을 진심으로
축하드립니다. 지난 10년간 대한민국의 비만 현황과 비만
관련 만성질환, 심혈관질환, 암 등에 대한 소중한 건강자료를
체계적으로 분석하여 「비만팩트시트」에 담아온 대한비만학회의
헌신적 노력은 국민 건강 증진에 크게 기여했다고
확신합니다. 앞으로도 「비만팩트시트」를 통한 지속적인 공익적
기여를 기대하며, 대한비만학회의 변함없는 발전을 응원합니다.

유순집
가톨릭의대 부천성모병원 내분비내과

대한비만학회 에서는 지난 십 년간 우리 국민의 생애
주기별 비만 및 대사 질환 치료에서 방향성을 제시
하여 새로운 지평을 열어 주었습니다.
앞으로도 비만 이라는 망망대해의 항로에서 등대의
역할을 잘 해 주시리라 믿고 축하드립니다.

이관우
아주의대 아주대병원 내분비대사내과

한국의 전체 국민 자료를 요약하여 Fact Sheet로
전달하신, 위원회의 땀으로 맞는 3650일 오늘을
축하합니다. 대한 비만 학회의 빅 데이터 자료가 세계의
학문적 중심으로 되는 20 주년 성년의 내일을 맞기를
기대하면서, 그간의 모든 위원들의 노력에 찬사를 보냅니다.

이규래
가천의대 가정의학과 (가천대 부속 동인천 길병원)

대한비만학회의 비만팩트시트 발간 10주년을
진심으로 축하드립니다. 많은 교수님들의
열정과 노고로 큰 성과를 이루어 내심에 기쁜
마음으로 축하드리고, 감사드립니다.

이원영
성균관의대 강북삼성병원 내분비대사내과

비만팩트시트는 한국의 비만 현실을 알기
쉽게 보여줬습니다. 지난 10년간 수고해주신
학회 임원진께 깊은 감사를 드립니다.

이창범
한양의대 구리병원 내분비대사내과

10주년
기념 10th

2025 OBESITY FACT SHEET

2025 비만 팩트시트

KOREAN SOCIETY FOR THE STUDY OF OBESITY

h·well 국민건강보험